Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Blépharoplastie supérieure / inférieure

Chirurgie des paupières

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Zone prévue : ☐ Paupières supérieures ☐ Paupières inférieures ☐ Paupières supérieures + inférieures

Technique pour la paupière inférieure : ☐ Transconjonctivale ☐ Sous-ciliaire (sous les cils) ☐ Sans objet _____

Gestes complémentaires : ☐ Repositionnement de la graisse ☐ Canthopexie / canthoplastie (soutien de la paupière) ☐ Aucun _____

Indication : ☐ Esthétique ☐ Fonctionnelle (rétrécissement du champ visuel) ☐ Les deux _____

Préoccupations et attentes du patient : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

Avec l'âge, la peau des paupières perd de son élasticité, le muscle qui entoure l'œil se relâche et la graisse de l'orbite peut faire saillie vers l'avant. Il en résulte un **excès de peau qui tombe** sur les paupières supérieures, ainsi que des **poches et des creux** sous les yeux. Une prédisposition génétique, l'exposition au soleil, le tabac et les variations de poids peuvent accélérer ce processus.

La blépharoplastie vise à donner à la région des yeux un aspect **plus frais, plus reposé et naturel**, en retirant l'excès de peau, de muscle et de graisse, ou en repositionnant la graisse. L'affaissement de la paupière supérieure peut parfois être suffisamment important pour rétrécir la partie supérieure du champ visuel ; l'intervention a alors aussi un but fonctionnel : **élargir le champ visuel**.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

La blépharoplastie seule ne corrige pas un sourcil bas, une paupière tombante due à une faiblesse du muscle releveur de la paupière (ptosis), les rides fines (pattes-d'oie) ni les cernes foncés sous les yeux ; ces situations peuvent nécessiter d'autres traitements.

2 Comment se déroule l'intervention ?

Avant l'intervention, vos yeux sont examinés — la vision, la production de larmes et le fonctionnement des paupières sont évalués — et des photographies sont prises. Si nécessaire, l'avis d'un ophtalmologiste sera demandé.

1. **Marquage :** La quantité de peau à retirer est soigneusement marquée alors que vous êtes en position assise, les yeux ouverts puis fermés.
2. **Paupière supérieure :** L'incision est placée dans le pli naturel de la paupière, de sorte qu'elle reste cachée dans ce pli lorsque vos yeux sont ouverts. L'excès de peau et, si nécessaire, une fine bande de muscle et la graisse en saillie sont retirés.
3. **Paupière inférieure – technique transconjonctivale :** L'incision est réalisée sur la face interne de la paupière, si bien qu'aucune cicatrice n'est visible à l'extérieur. La graisse à l'origine des poches est retirée ou repositionnée pour combler le creux sous l'œil.
4. **Paupière inférieure – technique sous-ciliaire :** S'il existe aussi un excès de peau, l'incision est réalisée juste sous les cils et l'excès de peau et de muscle est retiré. La cicatrice devient généralement peu visible avec le temps.
5. **Soutien de la paupière (canthopexie/canthoplastie) :** Si la paupière inférieure est relâchée, des points de soutien sont placés au coin externe de l'œil afin d'éviter que la paupière ne soit tirée vers le bas après l'intervention.
6. **Fermeture :** Les incisions sont refermées par des points très fins, qui sont généralement retirés **entre le 5e et le 7e jour**. Une pommade protectrice est appliquée sur l'œil.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie locale (± sédation) ou anesthésie générale	Environ 1 à 3 heures	Généralement sortie le jour même ; une nuit peut être nécessaire après une anesthésie générale

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Une région des yeux d'aspect plus frais, plus reposé et plus jeune
- Moins de lourdeur des paupières supérieures ; une vision plus confortable si l'affaissement rétrécit le champ visuel
- Réduction des poches des paupières inférieures et une transition plus harmonieuse sous l'œil

La plupart des patients sont satisfaits du résultat, et l'effet dure généralement de nombreuses années ; toutefois, le vieillissement se poursuivant, la peau peut à nouveau se relâcher avec le temps. Environ **2 à 5 patients sur 100** peuvent avoir besoin d'une petite retouche en raison d'une asymétrie, d'une correction insuffisante ou d'une cicatrice. Le résultat définitif apparaît généralement en **3 à 6 mois**.

4 Autres options thérapeutiques

- **Ne pas se faire opérer :** Comme il s'agit d'une intervention esthétique, vous avez toujours la possibilité de ne pas la faire.
- **Comblement de la vallée des larmes :** Peut camoufler temporairement un léger creux sous l'œil ; il ne corrige pas les poches ni l'excès de peau et comporte ses propres risques spécifiques.
- **Lifting du sourcil par toxine botulique :** Dans les cas légers, relever le sourcil de quelques millimètres peut ouvrir légèrement la paupière supérieure ; l'effet est temporaire.
- **Lifting du sourcil (lifting temporal / lifting du front) :** Si le problème sous-jacent est un sourcil bas, cette intervention peut être plus adaptée, à la place de la blépharoplastie ou en complément de celle-ci.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Traitements de resurfaçage cutané (laser, peeling chimique, radiofréquence) :** Peuvent améliorer les rides fines et la qualité de la peau ; ils ne suppriment pas un excès de peau important ni les poches.

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si l'intervention n'est pas réalisée, l'aspect actuel de vos paupières persistera et pourra lentement s'accentuer avec l'âge. Si l'affaissement de la paupière supérieure rétrécit votre champ visuel, cela peut s'aggraver avec le temps ; toutefois, cela ne représente généralement pas de danger urgent pour la santé de l'œil.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Des analyses de sang sont réalisées avant l'intervention ; si une anesthésie générale ou une sédation est prévue, vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste et devrez être à jeun au préalable.
- Signalez-nous impérativement si vous souffrez de **sécheresse oculaire, de glaucome, d'une maladie de la thyroïde ou si vous avez déjà subi une chirurgie des yeux (par ex. correction de la vue au laser)**.
- Si vous portez des lentilles de contact, ne les portez pas le jour de l'intervention ; vous devrez porter des lunettes après l'intervention.
- Ne portez ni maquillage des yeux, ni extensions de cils, ni crème pour le visage le jour de l'intervention. Après une sédation ou une anesthésie générale, vous ne devez pas conduire ; veuillez rentrer chez vous accompagné(e).
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Premières 48 heures	Un gonflement, une sensation de tiraillement, un léger suintement et des ecchymoses (bleus) autour des yeux peuvent apparaître. La douleur est généralement légère. Dormir la tête surélevée et appliquer des **compresses froides** aident à réduire le gonflement. Un larmoiement, une sensibilité à la lumière et une vision trouble temporaire (due à la pommade) peuvent survenir.
1re semaine	Les points sont généralement retirés **entre le 5e et le 7e jour**. Les ecchymoses et le gonflement diminuent nettement. Les gouttes/pommades oculaires sont utilisées selon les consignes. La plupart des patients reprennent un travail de bureau et leur vie sociale en 7 à 10 jours ; les ecchymoses peuvent être masquées par du maquillage.
2e à 4e semaine	Le gonflement résiduel diminue. Les lentilles de contact peuvent généralement être portées après **2 semaines**. Le sport intense et les travaux nécessitant de se pencher doivent être reportés d'environ 2 à 3 semaines. Attendez l'accord de votre médecin avant de nager ou de porter du maquillage pour les yeux.
1er au 6e mois	

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

La rougeur de la cicatrice s'estompe progressivement et la cicatrice devient difficile à voir dans le pli de la paupière. La forme définitive et la symétrie des paupières se stabilisent généralement en **3 à 6 mois**.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Gonflement et tiraillement autour des yeux ; les ecchymoses, **si elles apparaissent**, disparaissent en 1 à 2 semaines
- Larmoiement, sensation de sécheresse ou de sable, picotements et sensibilité à la lumière (premiers jours)
- Légère difficulté à fermer complètement les yeux les premiers jours
- Rougeur, légère induration et engourdissement le long de l'incision

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Sécheresse oculaire** — Environ **10 à 25 patients sur 100** ressentent des picotements, une brûlure ou une sensation de sécheresse ; cela s'améliore généralement avec des gouttes oculaires en quelques semaines à quelques mois. Cela peut être plus marqué et durer plus longtemps chez les personnes souffrant déjà de sécheresse oculaire.
- **Gonflement du blanc de l'œil (chémosis)** — Gonflement par du liquide de la membrane qui recouvre le blanc de l'œil, observé en particulier après une chirurgie de la paupière inférieure. Il disparaît généralement en quelques semaines avec des gouttes et des compresses.
- **Impossibilité de fermer complètement les yeux (lagophtalmie)** — Une fermeture incomplète des yeux pendant le sommeil est fréquente au cours des premières semaines après une chirurgie de la paupière supérieure et disparaît généralement d'elle-même. Une pommade de nuit est recommandée pour protéger l'œil pendant cette période. Elle est rarement permanente (**moins de 1 patient sur 100**).
- **Petits kystes (milia) et marques de points** — De petits points blancs peuvent se former le long de l'incision ; ils disparaissent d'eux-mêmes ou sont retirés par un geste simple.

Situations peu fréquentes

- **Paupière inférieure tirée vers le bas ou retournée vers l'extérieur (rétraction palpébrale, ectropion)** — Après une chirurgie de la paupière inférieure, chez environ **1 à 5 patients sur 100** (plus souvent avec la technique sous-ciliaire), la paupière inférieure peut être tirée vers le bas, le blanc de l'œil peut être davantage visible sous l'iris, ou la paupière peut se retourner vers l'extérieur. La plupart des cas s'améliorent avec des massages et la pose de bandes adhésives ; si cela persiste, cela peut entraîner une sécheresse et un larmoiement de l'œil, et une **chirurgie correctrice** peut être nécessaire.
- **Asymétrie et correction insuffisante ou excessive** — Des différences de hauteur ou de forme du pli peuvent persister entre les deux paupières ; si trop de peau est retirée, la fermeture des yeux peut être difficile, et si trop de graisse est retirée, un aspect creusé peut apparaître. Une retouche peut être nécessaire.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Modification de la forme du coin de l'œil** — Lorsqu'un soutien de la paupière (canthopexie/canthoplastie) est réalisé, le coin externe de l'œil peut paraître tendu, relevé ou arrondi pendant un certain temps, ou différer d'un côté à l'autre. Dans la plupart des cas, cela s'atténue en quelques semaines à quelques mois, à mesure que le gonflement diminue ; parfois, une retouche est nécessaire.
- **Apparition d'une paupière tombante (ptosis)** — Une faiblesse du muscle releveur de la paupière, auparavant masquée par l'excès de peau, peut devenir visible après l'intervention ; elle peut nécessiter une correction par une intervention distincte.
- **Cicatrice visible ou épaissie** — La peau des paupières cicatrise généralement très bien ; rarement, la cicatrice peut rester visible, ou une fine bride peut se former au coin interne de l'œil (palmure).
- **Saignement et accumulation de sang (hématome)** — Une accumulation de sang sous la peau survient chez environ **1 patient sur 100** ; elle se résorbe généralement d'elle-même, mais si elle est importante, il peut être nécessaire de l'évacuer.
- **Infection** — Les paupières étant très bien vascularisées, l'infection est rare (**moins de 1 patient sur 100**) ; si elle survient, elle est traitée par antibiotiques.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Saignement derrière l'œil et perte de la vue** — Il s'agit de la complication la plus grave, mais très rare. Un saignement derrière l'œil survient chez environ **1 patient sur 2 000** et peut comprimer le nerf optique. S'il n'est pas reconnu rapidement et traité en urgence (ouverture des points, évacuation du sang, médicaments, chirurgie en urgence), il peut entraîner une **perte définitive de la vue**. Une perte définitive de la vue a été rapportée chez environ **1 patient sur 10 000 à 40 000** ou moins. C'est pourquoi les signes d'alerte au cours des 48 premières heures sont si importants.
- **Vision double** — Due à l'atteinte, lors d'une chirurgie de la paupière inférieure, d'un petit muscle qui fait bouger l'œil (muscle oblique inférieur) ; elle est généralement temporaire, très rarement permanente, et peut nécessiter un traitement complémentaire ou une intervention.
- **Éraflure ou ulcère de la cornée** — Une éraflure peut se produire à la surface transparente à l'avant de l'œil, provoquant douleur, sensation de sable et larmoiement ; elle guérit généralement en quelques jours avec des gouttes. Très rarement, un traitement oculaire de longue durée peut être nécessaire.
- **Problèmes d'écoulement des larmes** — Un larmoiement dû à une atteinte du canal lacrymal est très rare.
- **Insatisfaction psychologique** — Malgré un résultat techniquement réussi, une personne peut avoir du mal à s'adapter à sa nouvelle apparence. Discuter ouvertement des attentes avant l'intervention réduit ce risque.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Douleur intense et croissante de l'œil**, surtout d'un seul côté
- **Œil qui fait saillie vers l'avant**, ou gonflement tendu et ecchymoses des paupières augmentant rapidement
- **Baisse de la vision**, assombrissement de la vision, vision double ou limitation des mouvements de l'œil
- Douleur de l'œil accompagnée de nausées ou de vomissements
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, rougeur, écoulement ou douleur croissants au niveau de l'incision
- Sensibilité marquée à la lumière et sensation de sable qui ne disparaît pas
- **Si l'un de ces signes survient au cours des 48 premières heures, chaque minute compte : appelez immédiatement ou rendez-vous au service d'urgences le plus proche.**

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Appliquez des compresses froides à intervalles réguliers pendant les 48 premières heures ; dormez sur le dos, la tête surélevée.
- Ne vous frottez pas les yeux. Les premiers jours, évitez de soulever des charges lourdes, de vous pencher, de forcer (efforts de poussée) et les activités qui augmentent le risque de saignement.
- Utilisez les gouttes et pommades oculaires qui vous ont été remises aussi souvent que recommandé ; si vos yeux ne se ferment pas complètement, appliquez toujours la pommade de nuit.
- En règle générale, ne portez pas de lentilles de contact pendant 2 semaines ni de maquillage pour les yeux pendant 1 à 2 semaines. Portez des lunettes de soleil à l'extérieur et faites des pauses fréquentes devant les écrans.
- Si vous venez de l'étranger, prendre l'avion est généralement sans danger après le retrait des points (entre le 5e et le 7e jour).
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

- ☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.
- ☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.
- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ Je comprends que la blépharoplastie seule ne corrige pas un sourcil bas, une paupière tombante due à une faiblesse du muscle releveur de la paupière, les rides fines ni la coloration foncée sous les yeux.
- ☐ Je comprends que si je ressens une douleur intense de l'œil, un gonflement ou une baisse de la vision au cours des 48 premières heures suivant l'intervention, je dois consulter **immédiatement**.
- ☐ Je comprends que cette intervention est **à visée esthétique**, qu'elle n'est pas médicalement nécessaire et que j'ai toujours la possibilité de ne pas la faire. J'ai discuté de mes attentes avec mon médecin, et le résultat réaliste pouvant être obtenu m'a été expliqué.
- ☐ Je comprends qu'une symétrie parfaite ou la reproduction exacte de l'apparence d'une photographie ne peuvent être garanties, que le résultat final dépend de la cicatrisation de mes tissus et que, dans certains cas, une intervention de correction peut être nécessaire.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien avec le patient :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.

☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.